

Epistaxis: manejo en APS y derivación

1. Introducción y relevancia clínica

La **epistaxis** es el **sangrado originado en la mucosa nasal**, una de las urgencias ORL más frecuentes tanto en atención primaria como hospitalaria.

A lo largo de la vida, **más del 60% de las personas** presenta al menos un episodio, aunque solo un pequeño porcentaje requiere atención médica.

Relevancia clínica

- Representa hasta el **10% de las consultas ORL en servicios de urgencia**.
 - En la mayoría de los casos es **autolimitada y benigna**, pero en algunos pacientes puede ser **recurrente o severa**, requiriendo hospitalización o taponamiento.
 - Su reconocimiento, manejo inicial y derivación oportuna son **competencias esenciales en el EUNACOM clínico** y en la práctica médica general.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía relevante

La nariz está irrigada por ramas de los sistemas **carotídeo externo e interno**:

- **Carótida externa** → **arteria esfenopalatina y facial**.
- **Carótida interna** → **arteria etmoidal anterior y posterior**.

Estas arterias se anastomosan en la **área de Kiesselbach o plexo de Little** (tabique anterior), responsable del **90% de las epistaxis**.

El 10% restante se origina en la **porción posterior (arteria esfenopalatina)**, más profunda y de mayor riesgo hemorrágico.

2.2 Tipos de epistaxis

Tipo	Localización	Características clínicas
Anterior (80–90%)	Plexo de Kiesselbach (tabique anterior)	Sangrado visible por narina anterior, fácil control local.
Posterior (10–20%)	Arteria esfenopalatina o etmoidales	Sangrado más abundante, puede fluir hacia faringe, difícil de controlar.

2.3 Fisiopatología

La mucosa nasal es muy vascularizada y susceptible a lesiones por:

- **Trauma local:** digital, manipulación, cirugía nasal.
 - **Inflamación local:** rinitis, sinusitis, exposición a aire seco.
 - **Trastornos sistémicos:** hipertensión, coagulopatías, anticoagulantes.
 - **Fragilidad vascular:** telangiectasias, aterosclerosis.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones clínicas

- **Sangrado nasal unilateral o bilateral.**
 - En epistaxis anterior, el sangrado sale por una fosa nasal.
 - En epistaxis posterior, el sangrado puede **flujo hacia la faringe** o **ambas narinas**.
 - Puede acompañarse de **tos, náuseas o hematemesis** (por deglución de sangre).
 - En casos graves: **mareo, palidez, taquicardia, hipotensión**.
-

3.2 Anamnesis dirigida

Debe incluir:

- Inicio y frecuencia de episodios.
- Factores desencadenantes (trauma, rinitis, esfuerzo).
- Antecedentes de **hipertensión, anticoagulantes, AAS, hemopatías**.
- Síntomas asociados: obstrucción nasal, epistaxis recurrente unilateral (sospecha tumoral).

3.3 Diagnóstico diferencial

Causa / Entidad	Características
Rinitis o sinusitis aguda	Congestión y mucosa eritematosa; sangrado leve.
Desviación septal con costras	Epistaxis recurrente unilateral.
Telangiectasia hemorrágica hereditaria	Historia familiar, epistaxis frecuentes desde la infancia.
Neoplasias nasales (ej. angiofibroma juvenil)	Epistaxis profusa recurrente en varones jóvenes.
Trastornos hematológicos	Equimosis, petequias, sangrados en otros sitios.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

- En la mayoría de los casos, el diagnóstico es **clínico**, mediante inspección y antecedentes.
 - El objetivo inicial es **localizar el sitio de sangrado** y valorar su severidad.
-

4.2 Exámenes útiles según contexto

Examen	Indicación
Hemograma y hematocrito	Epistaxis moderada a severa o recurrente.
Tiempo de protrombina y TTPa	Pacientes con anticoagulantes o sospecha de coagulopatía.
Función renal y hepática	Sangrado prolongado, uso de anticoagulantes.
Endoscopía nasal rígida/flexible	Para localizar fuente de sangrado posterior o recurrente.
TAC de cavidades nasales	Sospecha de tumor o malformación vascular.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Manejo inicial en APS

El enfoque se basa en el **ABC** de urgencias:

1. **Asegurar vía aérea y estabilidad hemodinámica.**
 2. **Determinar localización (anterior o posterior).**
 3. **Controlar el sangrado local.**
-

5.2 Medidas generales

- Posición **sentada con leve inclinación hacia adelante** (evita aspirar sangre).
- **Compresión digital** del tercio inferior del tabique (ala nasal) durante **10–15 minutos continuos**.
- Aplicar **compresas frías** en dorso nasal o cuello.
- **No inclinar la cabeza hacia atrás.**

Si el sangrado cesa: limpiar, educar y prevenir recurrencias.

Si persiste: avanzar a manejo específico.

5.3 Manejo específico según tipo

A. Epistaxis anterior leve o moderada

1. **Inspección con aspiración suave.**
 2. **Aplicar anestésico y vasoconstrictor local:**
 - Lidocaína + oximetazolina o adrenalina diluida.
 3. **Cauterización química:**
 - **Nitrato de plata al 75%**, sobre el punto sangrante.
 - *Nunca cauterizar ambos lados del tabique simultáneamente → riesgo de perforación.*
 4. **Taponamiento anterior:**
 - Gasa con vaselina o taponamiento nasal expandible (Merocel®).
 - Retirar a las **24–48 horas**.
 - Indicar **amoxicilina/ácido clavulánico 875/125 mg c/12h** para prevenir infección o sinusitis.
-

B. Epistaxis posterior o severa

Sospechar si:

- Sangrado bilateral o por la faringe.
- Sangrado no controlable con medidas anteriores.
- Paciente anciano o con HTA / anticoagulación.

Manejo:

- Taponamiento posterior con sonda Foley nº 12–14 (inflar balón 10 ml).
- Derivar urgente a **ORL o servicio de urgencia hospitalaria**.
- Mantener monitoreo y fluidos EV si hay inestabilidad.

5.4 Tratamiento etiológico

Causa	Manejo específico
Hipertensión arterial	Control con antihipertensivos.
Anticoagulantes / AAS	Suspender temporalmente según riesgo trombótico.
Rinitis crónica o costras	Lavados salinos y pomadas lubricantes.
Telangiectasia hereditaria	Derivación a ORL especializado.
Neoplasia o angiofibroma	Evaluación quirúrgica / embolización.

5.5 Educación y prevención

- Evitar sonarse o manipular la nariz 24–48h postevento.
- Evitar ambientes secos, humo y ejercicio intenso.
- Uso de **pomadas nasales humectantes** (vaselina líquida, suero fisiológico).
- Controlar **HTA y uso de anticoagulantes**.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Recurrencia	Frecuente si no se trata causa subyacente.
Infección sinusal o absceso	Por taponamiento prolongado.
Hipovolemia / shock	En epistaxis posterior severa.
Necrosis septal	Por cauterización bilateral o presión excesiva.
Toxicidad por lidocaína o adrenalina	Si uso excesivo de anestésico local.

Pronóstico:

Excelente en epistaxis anterior controlada.

Epistaxis posterior o recurrente requiere manejo especializado.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Epistaxis anterior** = **plexo de Kiesselbach**; **control local y compresión eficaz**.
 2. **Epistaxis posterior** se sospecha si sangrado persistente o flujo hacia faringe.
 3. Siempre evaluar **fármacos anticoagulantes o AAS**.
 4. **No inclinar la cabeza hacia atrás**, el paciente debe estar **inclinado hacia adelante**.
 5. **No cauterizar ambos lados del tabique**.
 6. **Taponamiento posterior** = **derivación inmediata**.
 7. En **niños con epistaxis unilateral y secreción fétida**, descartar **cuerpo extraño**.
-

Errores comunes

- No mantener compresión continua el tiempo suficiente.
 - Usar cauterización bilateral o sin identificar el punto sangrante.
 - No investigar causas sistémicas (HTA, coagulopatías).
 - Retirar el taponamiento sin antibioticoterapia.
 - Omitir derivación ante sangrado posterior o masivo.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **epistaxis** es un sangrado nasal común, generalmente **anterior y autolimitado**.
2. La mayoría se origina en el **plexo de Kiesselbach (área de Little)**.
3. El **manejo inicial** consiste en compresión nasal, vasoconstrictor local y cauterización.
4. **Epistaxis posterior o severa** requiere **taponamiento posterior y derivación urgente**.
5. Siempre evaluar **HTA, uso de anticoagulantes o coagulopatías**.

6. **Evitar cauterizar ambos lados del tabique** para prevenir perforación.
7. **Prevención:** humectación nasal, evitar trauma y control de comorbilidades.